EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 72345
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 13-10-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ELCIRA SANHUEZA VILLAGRA			RUN	: 6.716.516-0
F.Nac	: 07-12-1951	Edad	: 71 AÑOS, 10 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: IGNACIO CARRERA PINTO Nº 320			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-02	Fecha Egreso	: 13-10-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Infección respiratoria alta tratada
2. DHC no OH Child Pugh score B
a. Síndrome de Hipertensión portal - Trombocitopenia 2ria.
3. ICC descompensada
4. HTA - DM
5. Hemorragia uterina disfuncional: Miomatosis uterina.
a. Anemia severa N/N transfundida
6. Obesidad Mórbida
7. Limitación moderada para ABVD

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. D50-ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. C54.1-TUMOR MALIGNO ENDOMETRIO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de Obesidad, HTA, DM2, ICC, Obs Ca endometrial en estudio, es traída por familiar por cuadro de disnea y tos de 3 días de evolución. Antecedentes de hospitalización en agosto por ICC, en espera de control por med interna CAE.
Exámenes de laboratorio de ingreso crea: 1.2, lactato 2.7, PCR: 141, hb: 5.1, leucocitos 12700, inr 2.09, troponina 17. ECG destaca taquicardia sinusal. Rx de tórax en similares condiciones a 29/08/23.
Al examen físico destaca Vigil, OTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs, disneica, Cardiaco RR2T NAS, Pulmonar MP (+) disminuido en las bases, Extremidades edema ++/+++ bilateral. Ingresa con 3 lts por naricera. Se hospitaliza para manejo ICC descompensada + IRB y anemia. Actualmente bien hidratada y perfundida, con rr2t, nas, mp + hasta las bases algo disminuido, sra, EEII edema +++,signo fóvea ++.
Paciente sin requerimientos de 02, con buena tolerancia al manejo depletivo, sin signos de sangrado activo.
Buena tolerancia a kinesioterapia hoy se decide alta con HODOM

PLAN DE MANEJO:

HODOM para rehabilitación kinésica
Mantener terapia depletiva
Control Poli de medicina en 3 semanas

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen con restricción hídrica 1000cc/24hrs
2. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
3. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
5. FENOTEROL/ IPRATROPIO NEBULIZAR 0.5 MILIGRAMOS / 0.25 MILIGRAMOS NBZ 1 ml + 2 ml solución cada 6 hrs
6. ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 4 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
7. LACTULOSA SOLUCIÓN 65% FRASCO 200 MINILITROS 20 ml vo cada 8 hrs

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO